

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re CTI

Lutte contre les comportements préjudiciables à la santé reproductive

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Consigne : Analysez les documents et situations cliniques ci-après. Vos réponses doivent mobiliser vos connaissances en physiologie de la reproduction, épidémiologie et santé publique, et faire preuve d'esprit critique.

EXERCICE 1 Analyse d'une situation clinique complexe : grossesse précoce et avortement à risque

Une patiente de 16 ans, scolarisée en classe de Première, consulte aux urgences gynécologiques pour douleurs pelviennes intenses, fièvre ($39,2^{\circ}\text{C}$) et métrorragies abondantes survenues 48 heures après une tentative d'interruption de grossesse réalisée dans des conditions d'asepsie douteuses. L'échographie pelvienne révèle une cavité utérine vide mais un épanchement liquidien important dans le cul-de-sac de Douglas. Le test de grossesse urinaire (Ξ -hCG) reste fortement positif. L'interrogatoire rétrospectif révèle un rapport sexuel non protégé unique 8 semaines plus tôt, absence de contraception par méconnaissance des méthodes et refus parental de toute discussion sur la sexualité.

1. À partir des signes cliniques et paracliniques, établissez le diagnostic topographique et étiologique probable. Justifiez chaque élément de votre raisonnement physiopathologique (2 pts).
2. Expliquez les mécanismes physiologiques par lesquels la tentative d'avortement clandestin a pu entraîner le tableau de péritonite pelvienne observé. Intégrez la notion de barrière utérine et de flore vaginale (2 pts).
3. Évaluez la responsabilité respective des trois niveaux de prévention (primaire, secondaire, tertiaire) dans la survenue de ce cas. Pour chacun, proposez une mesure concrète, applicable au contexte camerounais, qui aurait pu modifier l'issue (3 pts).
4. La patiente exprime le souhait de ne plus jamais revivre cette situation. Parmi les méthodes contraceptives réversibles à longue durée d'action (LARC), laquelle est physiologiquement la plus adaptée à une adolescente nullipare ? Justifiez votre choix par son mode d'action, son observance et son profil d'effets secondaires (2 pts).

EXERCICE 2 Interprétation critique de données épidémiologiques et décision en santé publique

Le tableau ci-dessous présente des indicateurs de santé reproductive pour deux régions hypothétiques (A et B) du Cameroun, issues de la même enquête DHS (Demographic and

Health Survey).

Indicateur	Région A (Urbaine)	Région B (Rurale)	Écart (B-A)	Signification statistique (p)
Taux de fécondité des adolescentes (15-19 ans) / 1000	85	165	+80	< 0,001
Prévalence contraceptive moderne (femmes en union)	32%	12%	-20%	< 0,001
% Grossesses non désirées aboutissant à un avortement	45%	68%	+23%	< 0,01
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 NV)	350	780	+430	< 0,001
% Femmes ayant eu 1 ^{er} rapport avant 15 ans	12%	28%	+16%	< 0,001
Accès à l'éducation sexuelle complète (ESC) à l'école	65%	18%	-47%	< 0,001

1. Identifiez, en vous basant uniquement sur les données du tableau, les deux déterminants proximaux (facteurs intermédiaires) les plus fortement corrélés à l'excès de mortalité maternelle observé en Région B. Argumentez statistiquement (2 pts).
2. La corrélation ne prouve pas la causalité. Proposez une variable confondante majeure, non présente dans le tableau, qui pourrait expliquer simultanément la précocité des rapports, la faible contraception et la mortalité élevée. Expliquez le mécanisme de confusion (2 pts).
3. En tant qu'expert MINESEC chargé de concevoir une intervention « École-Santé » prioritaire pour la Région B, hiérarchisez trois actions concrètes (curriculum, forma-

tion enseignants, services de santé scolaires) en justifiant leur impact prévisible sur au moins deux indicateurs du tableau chacun (3 pts).

4. Discutez la limite éthique et épidémiologique d'une politique qui ciblerait exclusivement la distribution de contraceptifs d'urgence dans les lycées de la Région B, sans composante éducative (2 pts).

EXERCICE 3 Raisonnement physiopathologique et éthique : les complications de l'avortement incomplet

Un avortement incomplet (rétention de débris trophoblastiques dans la cavité utérine) évolue spontanément vers trois issues possibles : expulsion complète, hémorragie de la délivrance, ou infection ascendante (endométrite, salpingite, péritonite, septicémie).

1. Décrivez la cascade physiopathologique reliant la rétention trophoblastique à l'hémorragie massive, en intégrant le rôle de l'utérine atone, de la fibrinolyse locale et de l'absence de rétraction des artères spirales (2 pts).
2. Expliquez pourquoi la présence de tissu nécrosé et de sang coagulé dans l'utérus constitue un terrain de culture exceptionnel pour les germes anaérobies (ex : *Clostridium perfringens*) et les bacilles Gram négatif, en lien avec le pH, le potentiel d'oxydo-réduction et la vascularisation (2 pts).
3. Une patiente arrive en état de choc septique (PA 70 mmHg, FC 130 bpm, T° 39,5 °C, diurèse nulle) suite à un avortement incomplet non pris en charge depuis 72 heures. La laparotomie d'urgence révèle une péritonite purulente généralisée sans perforation utérine visible. Expliquez le mécanisme de passage de l'infection de la cavité utérine à la cavité péritonéale sans perforation macroscopique (2 pts).
4. Au vu du pronostic vital engagé, l'équipe médicale propose une hystérectomie totale d'urgence. La patiente, mineure de 17 ans, est inconsciente. Ses parents, présents, refusent l'hystérectomie pour « préserver sa future maternité », préférant un « nettoyage utérin » conservateur. En vous référant aux principes de l'éthique médicale (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) et au cadre légal camerounais (Code de la santé publique), analysez la décision que doit prendre le chirurgien. Argumentez (3 pts).

EXERCICE 4 Synthèse : Conception d'un programme de prévention intégré « Zéro Grossesse Non Désirée au Lycée »

Vous êtes chargé de rédiger la note conceptuelle d'un programme pilote pour 5 lycées de la ville de Yaoundé sur 2 ans. Le programme doit articuler : éducation sexuelle complète (ESC), accès aux services de santé adaptés aux adolescents (SSAA) et environne-

ment scolaire protecteur.

1. Définissez trois objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels) distincts ciblant respectivement : la connaissance (niveau élève), l'accès (niveau service), et la norme sociale (niveau communauté éducative) (3 pts).
2. Pour l'objectif « Accès », proposez un dispositif concret de liaison Lycée-Centre de Santé (ex : permanence infirmière, téléconsultation, distribution). Analysez deux freins systémiques majeurs (financement, confidentialité, personnel, rupture de stock) et un levier pour chacun (3 pts).
3. L'évaluation d'impact à 2 ans montre une baisse de 15 % des grossesses déclarées mais une augmentation de 10 % des IST déclarées chez les filles. Proposez trois hypothèses explicatives non mutuellement exclusives (comportementales, biomédicales, méthodologiques) et l'indicateur supplémentaire à collecter pour les discriminer (3 pts).